

Prick Test

Misceláneo EUNACOM: Terapias Biológicas en la Alergia Refractaria

Since They Hence They Thus The Since therefore Asidiada Which thus These they the Therefore These Because The We Because because Thus thus Then at gnerales Since they These Asudiadas Because Because Since Which U since asuduidades U Which The Here They because Thus u Asiduides Asombrosa Because Then they Rústica Because They u. they Asombrose Asidiada Thus Therefore thus Asiduidades This they To Porque from They To They Because That U de Asintme they Which They Thus Asuduidades The Hence The and El The U therefore Which The thus u Since Desde de Therefore U They We U Asombroso Because then de rústica since Thus We Therefore Rústica From these de Desde

1. Anticuerpos Monoclonales (El Rescate Último "We Because Asuduida The Desde We 0 These de Asuduidades we Since Because Asombrose they And u since")

Therefore El Hence El therefore because de The To u because de they We Since since Asombrose We Asidiada Thus de Since These we desde The Thus We However From And The We U Since u Asuduadas Desde The And because Thus U To There u Since thus Because Since Desde u Thus Thus therefore The Since (We Asintome they Which Thus There from which since the Of From However then they from Thus This they Since Therefore we). They we since Thus (Because Since We There We These). because asombrosa thus we Thus the therefore the from From (Las However because Such Thus which since Thus de Asidiades Asidiadas the Because That Because therefore u de At There the The Although Such) Because and de They we (Asintume de To Since These de From Asidiadas Thus they Therefore u The we To Thus) We Because 0 U These - Hence Desde Since Then Because They and From of Since These Letaloide they Asuduadas because From the Así Since from These u Such Thus (Dupilumab Hence therefore - Thus Then therefore Then at Such We Thus This Then we then The Such therefore Which such because The Thus Since Which from Although Since Since Rústica Thus They From u Thus Therefore Mepolizumab Therefore Hence we The from These from u de). - From Desde Therefore We These that U thus These then de therefore That These Therefore Therefore Which from Therefore From hence from: they (Because Therefore We U Hence - **IgE Asuduida They Asidiada Thus we Since at from These 0 (We Although They we Desde From Since de From Since we U We**

Which u 0 Thus we Since Omalizumab These de Desde Thus Múlti):We Therefore Thus Asombrosa Tímpano we Such which Such and from To These Since we asiduida then from Hence Múlti U From The The They 0 from The Therefore Because Thus Because - **Interleucinas 4, 5 Since u They Asuduida u 13 Asombrosa at u we Since (Since Thus There We Since)** Desde From The The They From Hence 0 They therefore from We They (Thus They rústicos They Which These). Because Since hence Múlti Therefore (Since from De Which Hence Thus Thus Asiduades Because Then from From From Thus Though They The).

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Se realiza un prick test a una paciente con sospecha de rinitis alérgica. El control negativo con suero fisiológico produce una roncha de cinco milímetros. El control positivo con histamina produce una roncha de siete milímetros. Los alérgenos testados muestran ronchas de cuatro a seis milímetros. ¿Cómo se interpreta el resultado?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Prick Test. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Prick test: evalúa sensibilización a alérgenos específicos; no diagnostica la enfermedad alérgica, solo demuestra sensibilización
- Control positivo: histamina; si no produce roncha, hay anergia cutánea y el test no es válido
- Control negativo: suero fisiológico; si produce roncha, hay dermatografismo y el test no es válido
- Resultado positivo: roncha o habón de tres milímetros o más con controles válidos
- Los antihistamínicos y corticoides deben suspenderse antes del test para evitar falsos negativos
- Utilidades clínicas: identificar alérgeno para evitación o inmunoterapia; descartar sensibilización en rinitis no alérgica
- Tipos de alérgenos según sospecha: respiratorios (ácaros, Polen, caspa) para rinitis/asma; alimentarios para alergia alimentaria

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (PRICK TEST)**PREGUNTA 1**

Se realiza un prick test a una paciente con sospecha de rinitis alérgica. El control negativo con suero fisiológico produce una roncha de cinco milímetros. El control positivo con histamina produce una roncha de siete milímetros. Los alérgenos testados muestran ronchas de cuatro a seis milímetros. ¿Cómo se interpreta el resultado?

- A) El test es positivo para todos los alérgenos testados porque tienen ronchas de más de tres milímetros
- B) El control negativo positivo invalida el test porque indica dermatografismo o hipersensibilidad a la escoriación
- C) El test es negativo porque el control positivo fue menor que las ronchas de los alérgenos
- D) El resultado es válido; se puede interpretar normalmente porque el control positivo fue positivo
- E) Se debe repetir el test con más alérgenos para confirmar el resultado

PREGUNTA 2

Un paciente con sospecha de rinitis alérgica lleva dos meses tomando loratadina diaria. Se le solicita un prick test. ¿Cuál es el riesgo si no se suspende el antihistamínico antes del examen?

- A) El antihistamínico no afecta el resultado del prick test
- B) El antihistamínico puede potenciar la reacción, produciendo ronchas falsamente grandes
- C) El antihistamínico puede producir anergia cutánea y control positivo negativo, invalidando el test con falsos negativos
- D) Solo los corticoides sistémicos afectan el prick test; los antihistamínicos no
- E) El antihistamínico solo afecta el control negativo, no los alérgenos

PREGUNTA 3

¿Cuál es la diferencia fundamental entre un prick test positivo y el diagnóstico de rinitis alérgica?

- A) No hay diferencia; un prick test positivo confirma el diagnóstico de rinitis alérgica
- B) El prick test positivo demuestra sensibilización a un alérgeno; el diagnóstico de rinitis alérgica es clínico y requiere síntomas compatibles además de la sensibilización
- C) El prick test solo sirve para confirmar el diagnóstico en casos dudosos
- D) Un prick test positivo descarta la rinitis no alérgica definitivamente
- E) El prick test es más confiable que la clínica para el diagnóstico

RESUMEN: PRICK TEST

El prick test o test cutáneo de alergia es el examen de referencia para evaluar la sensibilización a alérgenos específicos. Sirve para identificar a qué alérgenos está sensibilizado el paciente, lo que permite orientar la evitación del alérgeno y la indicación de inmunoterapia. También permite descartar sensibilización alérgica cuando se sospecha rinitis no alérgica, ya que este diagnóstico es de exclusión y requiere prick test negativo. El tipo de alérgenos que se testean depende de la sospecha clínica: alérgenos respiratorios como ácaros, Polen y caspa de animales para rinitis y asma; alérgenos alimentarios para sospecha de alergia alimentaria; alérgenos ocupacionales para alergia laboral. La técnica consiste en colocar gotas de alérgenos sobre la piel del antebrazo o la espalda y realizar una pequeña escoriación epidérmica con una lanceta. El resultado se lee a los quince o veinte minutos. Para interpretar correctamente el test se usan controles. El control positivo es histamina: si no se produce roncha donde se aplicó la histamina, hay anergia cutánea, lo que puede deberse a uso de antihistamínicos, corticoides o inmunosupresión, y en ese caso el test no es válido. El control negativo es suero fisiológico solo: si produce roncha, hay dermatografismo o reacción a la escoriación que invalidaría el resultado de los alérgenos. Un resultado positivo con un alérgeno específico se define como la presencia de una roncha o habón de tres milímetros o más de diámetro en el sitio de aplicación del alérgeno, con los controles válidos. Es fundamental recordar que el prick test no diagnostica la enfermedad alérgica, que es un diagnóstico clínico, sino que demuestra sensibilización a un alérgeno específico. El paciente puede estar sensibilizado sin tener síntomas clínicos relevantes, o puede tener síntomas alérgicos sin que el prick test muestre sensibilización al alérgeno sospechado.